

Scheda di valutazione pre-impianto a cura del prescrittore			
COGNOME _____ NOME _____		Data Nascita / /	
Indirizzo Via _____ N° _____ Località _____			
O caregiver O MdG O IFC di riferimento: nominativo _____		Tel _____	
Diagnosi principale:			
Dati clinici rilevanti	SI	NO	Note
Precedenti ed attuali dispositivi venosi			
Obesità			
Alterazione della coagulazione INR > 2			
Piastrinopenia			Valore
Assunzione di farmaci antiaggreganti/anticoagulanti			
Mobilità ridotta arti superiori			
Batteriemie			
Alterazioni anatomiche e patologiche del:			O Collo O Torace
Interventi chirurgici del collo o torace lato:			O Dx O Sx
Presente di Fibrillazione Atriale			P-M lato O Dx O Sx
O Radioterapia O Chemioterapia			
Presenza negli arti superiori di: O Dermatiti O Infezione O Edema			
Dialisi presenza di FAV			(SI) Criterio di esclusione
Preferenze di Lato			O Dx O Sx
Allergie (specificare)			

Richiesta di posizionamento di dispositivo venoso tipo:

	Centrale	Periferico
Scelta del dispositivo venoso	CICC	Midline
	PICC	Minimidine
	FICC	
	Port Toracico O PICC Port	Altro:
	Tunnellizzato	N° Lumi O 1 O 2 O 3

CONSENSO INFORMATO

IL MEDICO RICHIEDENTE: Dichiara di aver compilato il questionario insieme al paziente e richiede l'inserimento del dispositivo venoso per il paziente Nominativo _____ Data nascita ____/____/____

IL PAZIENTE: Ritiene di essere stato sufficientemente informato su rischi, controindicazioni, complicanze (All.3 e All.4), gestione del catetere proposto e dichiara di aver collaborato nel modo ottimale alla compilazione del questionario pertanto

☐ ACCONSENTE ☐ NON ACCONSENTE

All'introduzione del dispositivo indicato ; Data ____/____/____

Firma del paziente/genitore/tutore/amministratore _____

Firma e timbro del medico che acquisisce il consenso _____

IL PAZIENTE è altresì informato che può revocare in qualsiasi momento il consenso

REVOCA DEL CONSENSO

Firma del paziente/genitore/tutore/amministratore _____ Data ____/____/____

Firma e timbro del medico _____

INFORMAZIONI PER IL POSIZIONAMENTO DI ACCESSO VENOSO CENTRALE A LUNGO TERMINE

Io sottoscritto/a _____ dichiaro di essere stato informato dal Dott. _____ circa l'indicazione al posizionamento di un accesso venoso centrale a lungo termine per la somministrazione della chemioterapia e di eventuali altre terapie endovenose. Sono stato informato dell'esistenza di diversi tipi di cateteri venosi centrali, sistemi totalmente impiantabili e sistemi tunnellizzati. Il Team Accessi Vascolari in collaborazione con il medico richiedente ed in base ai criteri dell'algoritmo decisionale, è stato proposto:

O SISTEMA ESTERNO BREVE TERMINE

O SISTEMA TOTALMENTE IMPIANTABILE (Port) LUNGO TERMINE

O SISTEMA TUNNELIZZATO MEDIO-LUNGO TERMINE

Il sistema totalmente impiantabile (Port Toracico o PICC Port) è costituito da un serbatoio (o port) impiantato sottocute e da un catetere venoso centrale (CVC) a punta aperta o chiusa (Groshong) connessi fra loro tramite un sistema di raccordo. La scelta del sistema è stata fatta dal Team Accessi Vascolari in considerazione dell'uso prevalentemente discontinuo (periodico) ed ambulatoriale (day-hospital) del catetere stesso.

Principali vantaggi del sistema totalmente impiantabile (nei confronti dei sistemi esterni) sono:

- il miglior risultato estetico (preserva l'immagine corporea)
- la comodità di gestione (non necessita di medicazioni)
- la minima interferenza con le attività quotidiane
- consente attività come il nuoto e il bagno.

Principali svantaggi : • la cute deve comunque essere punta ogni volta (con aghi appositi che non danneggiano la membrana del serbatoio) • sono possibili stravasi da dislocazione dell'ago dal serbatoio • possono permanere danni cutanei cronici nel punto di inserzione dell'ago • non sono adatti alla somministrazione di elevate quantità di liquidi (basso flusso).

Sono a conoscenza del fatto che al posizionamento di un CVC a lungo termine possono seguire complicanze infettive e non infettive (ostruzione del sistema, problemi meccanici, trombosi venosa) che non sono significativamente diverse fra sistemi totalmente impiantabili e sistemi esterni. La manovra di inserimento di un CVC (tecnica percutanea) con allestimento di un tragitto sottocutaneo è eseguibile in anestesia locale e sotto controllo del corretto posizionamento intra-procedurale del catetere stesso con tecnica ECG intracavitario. I rischi della cateterizzazione venosa centrale sono generalmente di tipo immediato, ma si possono manifestare anche a distanza di ore: come ematomi o sanguinamenti interni e lesioni pleuriche con conseguente pneumotorace. Dopo le procedure di posizionamento del CVC verrà quindi controllato il suo corretto posizionamento. Soddisfatto delle informazioni ricevute, acconsento di sottopormi alla suddetta procedura. (All.2)

INFORMAZIONI SULL'INSERIMENTO DI PICC E MIDLINE

(a cura del sanitario responsabile dell'inserimento)

DEFINIZIONE : Il **PICC** è un catetere venoso centrale inserito per via periferica, il **Midline** è un catetere venoso periferico. Consentono accessi ripetuti al sistema vascolare per l'infusione di farmaci, di fluidi e di emoderivati. Vengono utilizzati anche per prelievi ematici.

TEMPO DI UTILIZZO: Il PICC può rimanere in sede per 3-6 mesi/1anno o per un periodo di tempo più lungo in assenza di complicanze. Il tempo di utilizzo del Midline è di 30 giorni o più in assenza di complicanze.

DOVE E COME SI INSERISCE Il catetere viene inserito in una vena dell'arto superiore (v. basilica o vv. brachiali) sotto guida ecografica; l'ecografo consente la localizzazione di vene periferiche non visibili né palpabili. Tale procedura minimizza le complicanze dell'impianto e post-impianto e viene eseguita in regime ambulatoriale. Durante la procedura viene utilizzata una piccola dose di anestetico locale per eseguire una piccola incisione cutanea. La punta del catetere raggiunge la vena cava superiore (PICC), la vena ascellare o la vena succlavia (MIDLINE). Il PICC può essere utilizzato immediatamente in caso di controllo del corretto posizionamento con metodo ECG intracavitario o controllo radiografico del torace.

A CHI VIENE POSIZIONATO IL PICC è indicato in pazienti che necessitano di infusione prolungata di qualsiasi tipo di farmaco e soluzione. La scelta del tipo di catetere (PICC o MIDLINE) dipende dalla durata e dal tipo di terapia. La manovra non richiede il digiuno né la sospensione delle eventuali terapie antiaggreganti / anticoagulanti in atto.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI • Abolizione rischi venipunture centrali • Infusione di liquidi vescicanti ed irritanti di qualunque PH e osmolarità, sangue ed emoderivati • Terapie endovenose protratte (6 mesi-1 anno) con bassa incidenza di complicanze trombotiche, infettive e sistemiche • Posizionamento in pazienti con terapia anticoagulante e/o piastrinopenici • Trattamenti continui ed intermittenti • Gestione anche a domicilio

CONTROINDICAZIONI Il posizionamento di PICC/MIDLINE è controindicato nelle seguenti situazioni: • Nota o sospetta batteriemia o setticemia • Pregressa radioterapia sul sito di inserimento previsto • Pregressi episodi di trombosi venosa o interventi di chirurgia vascolare nel sito di posizionamento previsto • Fattori locali in grado di prevenire l'adeguata stabilizzazione o accesso del dispositivo (eritemi, edemi, eczemi)

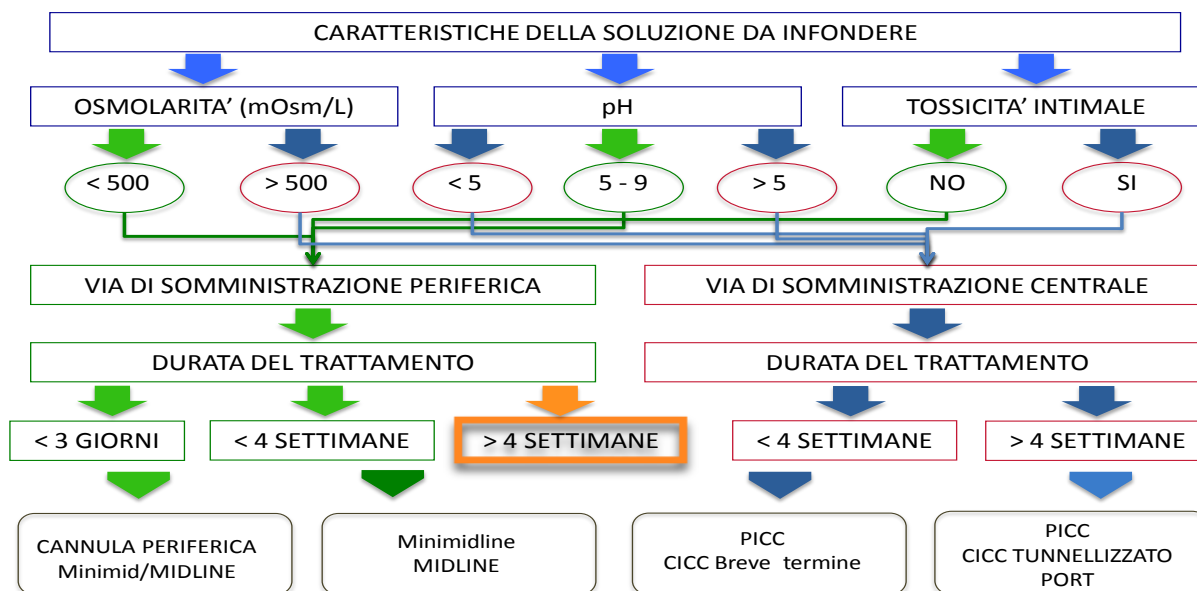
COMPLICANZE precoci e tardive:

- Impossibilità di impianto: con la tecnica eco guidata tale complicanza è sensibilmente ridotta
- Malposizionamento: per varianti anatomiche, a tale scopo si effettua la radiografia o altro metodo validato di controllo prima dell'utilizzo del sistema venoso.
- Puntura nervosa: (rara)
- Puntura arteriosa: con la tecnica eco guidata tale complicanza è molto rara
- Ematoma: può avvenire in sede di impianto, più facilmente in pazienti in terapia con anticoagulanti orali o piastrinopenici; di solito si risolve in pochi giorni senza la necessità di alcun intervento
- Aritmia cardiaca tardive
- Rottura del catetere
- Occlusione del catetere
- Flebite superficiale e/o profonda
- Infezione
- Trombosi superficiale e/o profonda
- Malposizionamento secondario.

Il sanitario responsabile dell'inserimento dichiara di aver fornito le informazioni e i chiarimenti richiesti

Data ____/____/____ L'operatore sanitario Firma assistito/genitore/amministratore.....

ALGORITMO Decisionale



INFORMAZIONI SULL'INSERIMENTO DI PICC E MIDLINE

(a cura del sanitario responsabile dell'inserimento)

DEFINIZIONE : Il **PICC** è un catetere venoso centrale inserito per via periferica, il **Midline** è un catetere venoso periferico. Consentono accessi ripetuti al sistema vascolare per l'infusione di farmaci, di fluidi e di emoderivati. Vengono utilizzati anche per prelievi ematici.

TEMPO DI UTILIZZO: Il PICC può rimanere in sede per 3-6 mesi/1anno o per un periodo di tempo più lungo in assenza di complicanze. Il tempo di utilizzo del Midline è di 30 giorni o più in assenza di complicanze.

DOVE E COME SI INSERISCE Il catetere viene inserito in una vena dell'arto superiore (v. basilica o vv. brachiali) sotto guida ecografica; l'ecografo consente la localizzazione di vene periferiche non visibili né palpabili. Tale procedura minimizza le complicanze dell'impianto e post-impianto e viene eseguita in regime ambulatoriale. Durante la procedura viene utilizzata una piccola dose di anestetico locale per eseguire una piccola incisione cutanea. La punta del catetere raggiunge la vena cava superiore (PICC), la vena ascellare o la vena succlavia (MIDLINE). Il PICC può essere utilizzato immediatamente in caso di controllo del corretto posizionamento con metodo ECG intracavitario o controllo radiografico del torace.

A CHI VIENE POSIZIONATO IL PICC è indicato in pazienti che necessitano di infusione prolungata di qualsiasi tipo di farmaco e soluzione. La scelta del tipo di catetere (PICC o MIDLINE) dipende dalla durata e dal tipo di terapia. La manovra non richiede il digiuno né la sospensione delle eventuali terapie antiaggreganti / anticoagulanti in atto.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI • Abolizione rischi venipunture centrali • Infusione di liquidi vescicanti ed irritanti di qualunque PH e osmolarità, sangue ed emoderivati • Terapie endovenose protratte (6 mesi-1 anno) con bassa incidenza di complicanze trombotiche, infettive e sistemiche • Posizionamento in pazienti con terapia anticoagulante e/o piastrinopenici • Trattamenti continui ed intermittenti • Gestione anche a domicilio

CONTROINDICAZIONI Il posizionamento di PICC/MIDLINE è controindicato nelle seguenti situazioni: • Nota o sospetta batteriemia o setticemia • Pregressa radioterapia sul sito di inserimento previsto • Pregressi episodi di trombosi venosa o interventi di chirurgia vascolare nel sito di posizionamento previsto • Fattori locali in grado di prevenire l'adeguata stabilizzazione o accesso del dispositivo (eritemi, edemi, eczemi)

COMPLICANZE precoci e tardive:

- Impossibilità di impianto: con la tecnica eco guidata tale complicanza è sensibilmente ridotta
- Malposizionamento: per varianti anatomiche, a tale scopo si effettua la radiografia o altro metodo validato di controllo prima dell'utilizzo del sistema venoso.
- Puntura nervosa: (rara)
- Puntura arteriosa: con la tecnica eco guidata tale complicanza è molto rara
- Ematoma: può avvenire in sede di impianto, più facilmente in pazienti in terapia con anticoagulanti orali o piastrinopenici; di solito si risolve in pochi giorni senza la necessità di alcun intervento
- Aritmia cardiaca tardiva
- Rottura del catetere
- Occlusione del catetere
- Flebite superficiale e/o profonda
- Infezione
- Trombosi superficiale e/o profonda
- Malposizionamento secondario.

Il sanitario responsabile dell'inserimento dichiara di aver fornito le informazioni e i chiarimenti richiesti
Data ____/____/____ L'operatore sanitario Firma assistito/genitore/amministratore.....